โครงการพัฒนากลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

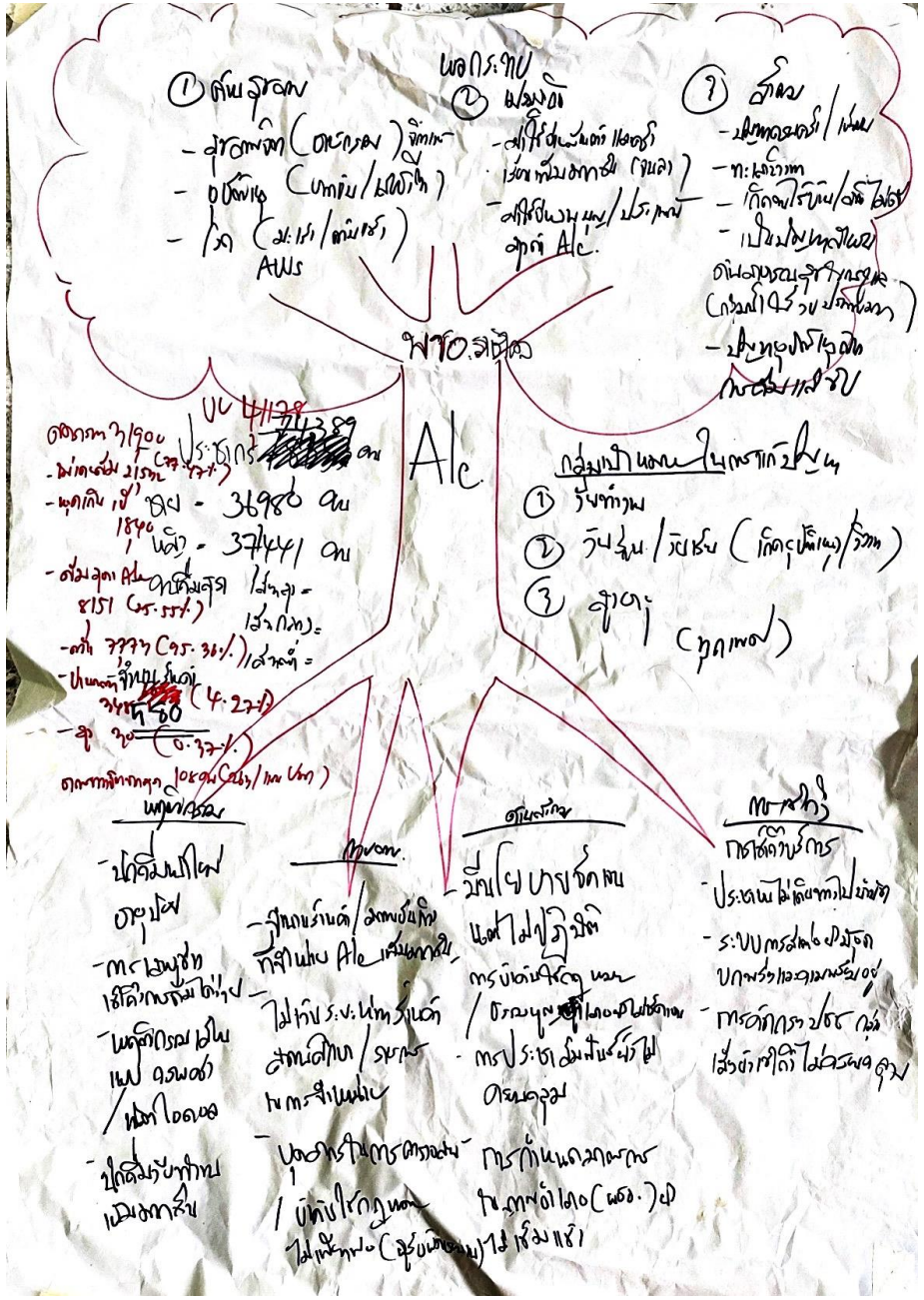
ประเด็นการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

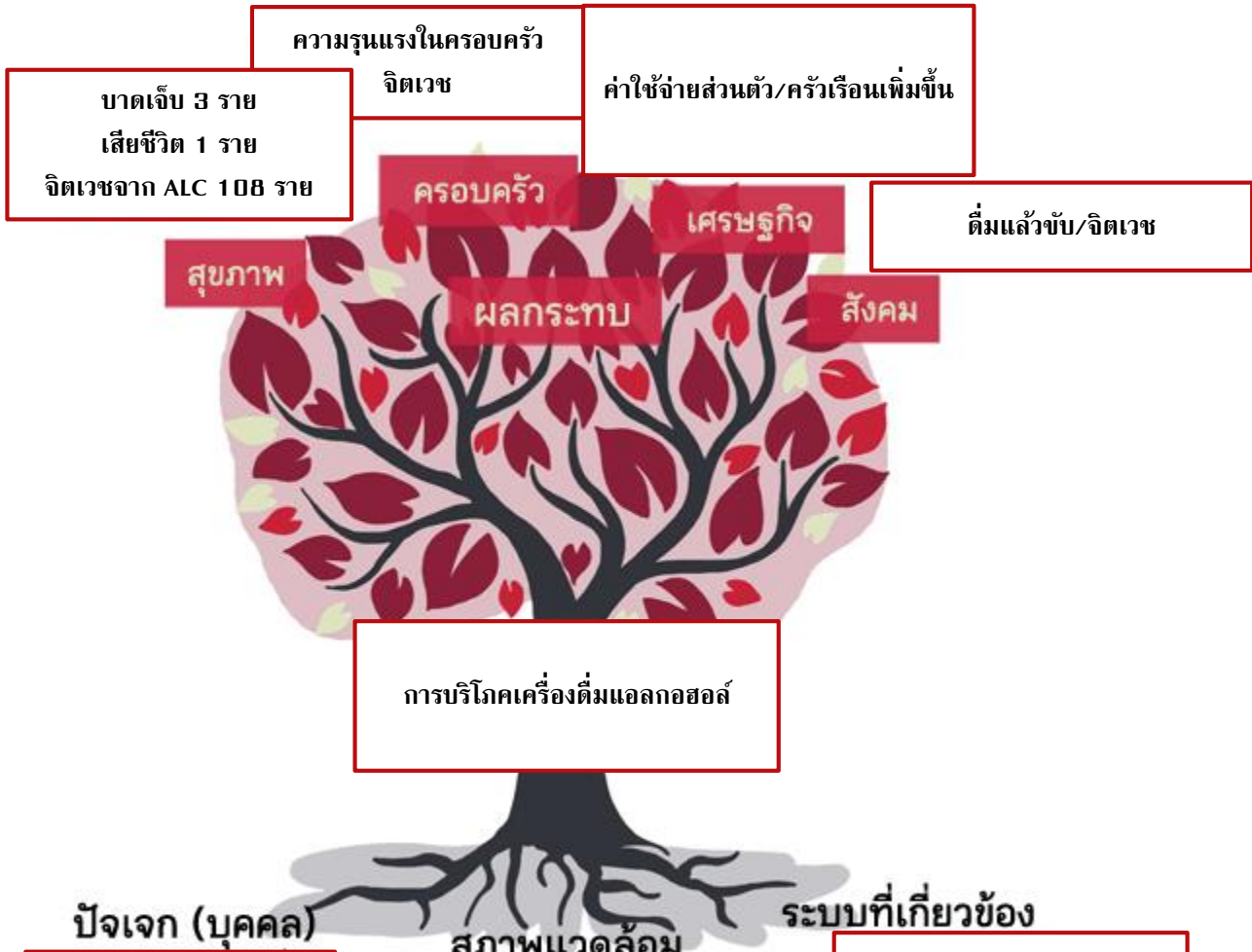
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

- **บริบทพื้นที่** อำเภอราษีไศล ตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ประมาณ 637 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 ตำบล และ 190 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง: 3 เทศบาล และ 11 อบต. ส่วนมากทำเกษตร ได้แก่ ปลูกข้าว หอมแดง พริก กระเทียม รวมถึงเลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์งานบ้านยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงกบ ปู หอย ชวนเรียนรู้จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหลังเกิดวิกฤติต่างๆ ประชากร จำนวน 74,514 คน ชาย 37,033 คน หญิง 37,481คน ส่วนมากเป็นประชากรวัยทำงานและสูงอายุ สถานศึกษา 18 แห่ง ร้านค้าร้านชำมากกว่า 200 ร้าน งานประเพณีและงานประจำอำเภอราษีไศล เช่นบุญบั้งไฟ บุญแข่งเรือยาว (ชิงถ้วยพระราชทาน) กีฬาอำเภอสานสัมพันธ์ (ชิงถ้วยพระราชทาน) งานงิ้ว งานสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์4ภาค งานลอยกระทง งานครบรอบวีรกรรมพระยากตะศิลา งานรำครบรอบก่อตั้งเมืองราศีไศล ณ โรงเรียนราศีไศล งานกีฬาราษีไศล ยูไนเต็ด (Rasisalai United) เป็นต้น

- **สถานการณ์ปัญหา** สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอราษีไศล ในปี 2567 พบว่ามีผู้ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 8,151 คน คิดเป็นร้อยละ 25.55 ดื่มในระดับเสี่ยงต่ำ จำนวน 7,773 คน คิดเป็นร้อยละ 95.36 ดื่มในระดับเสี่ยงปานกลาง จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 4.27 และดื่มในระดับเสี่ยงสูง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 (ข้อมูลจาก HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ,2567) ส่งผลกระทบที่สำคัญได้แก่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคนต่อเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,950 บาท รวมเป็นเงินที่สูญเสียต่อเดือนประมาณ 58,500 บาท การการเกิดอุบติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2566-2568 คิดเป็นร้อยละ 16.66 ,9.16 และ 20.22 ตามลำดับ และเสียชีวิตจำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.53 (สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลราษีไศล ,2568) รวมทั้งเกิดผลกระทบทางสังคมที่สำคัญกับประชาชนในพื้นที่อำเภอราษีไศล เช่น เยาวชนดื่มเหล้าแล้วขับรถเสียงดังก่อกวนในถนนสายหลักของอำเภอ เช่น ถนนหน้าราศีไศล - มหาชนะชัย สร้างความเดือนร้อนรำคาญ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นอกจากนี้ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลถึงด้านสุขภาพจิต โดยพบว่าปัญหาเป็นโรคจิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Psychoses) เป็นเวลานาน ปี 2567 จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ต่อแสนประชากร (สรุปข้อมูลปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลราษีไศล ,2567)

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล (ต่อ)





ปัจเจก (บุคคล)

นักดื่มหน้าใหม่/การเข้าถึงง่าย/พฤติกรรมเลียนแบบ/ขาดการตระหนักรู้ ความรู้ที่ถูกต้องปละผลกรทบต่อตนเองและครอบครัว

สภาพแวดล้อม

กายภาพ

ร้านค้าไม่เข้มงวดการจำหน่าย และร้านที่จำหน่ายใกล้สถานศึกษา

สังคม

ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย/การปชส.ธรรมนูญยังไม่ทั่วถึง/การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวด

ระบบที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

การคัดกรองไม่ครอบคลุม/ระบบส่งต่อไม่ต่อเนื่อง

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล (ต่อ)

แรงเสริม

-ผู้นำระดับชุมชนให้ความสำคัญ
-ผู้บริหารมีความ ตระหนักรู้
-การขับเคลื่อนของ พชอ. และพชต.
-มีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบลและอำเภอ
-มีการคัดกรองประจำทุกปี
-มีธรรมนูญอำเภอ/ตำบล

แรงต้าน

-ร้านค้า/สถานที่จำหน่ายอยู่ใกล้สถานศึกษา/ราชการ
-ค่านิยม/พฤติกรรมการเลียนแบบการดื่มแอลกอฮอล์
-งานบุญประเพณีไม่ได้มีข้อห้ามทุกงาน
-ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย

กิจกรรมส่งเสริม

-จัดประชุมผู้นำ/หัวหน้าส่วนเพื่อทำความเข้าใจ
-จัดอบรมแกนนำ
-ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
-ประกาศธรรมนูญอย่างทั่วถึง ครอบคลุม
-องค์กร/ร้านค้า สนับสนุนกิจกรรมตามกฎหมาย

กิจกรรมลดแรงต้าน

-รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางที่หลากหลาย
-คัดกรองอย่างจริงจัง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
-กำหนดรูปแบบ แนวทางในการทำงานที่ชัดเจน และมีระบบตั้งแต่ต้นทาง จนถึงผลลัพท์ มีเป้าหมายโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนากลไก พชอ. ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนด้วยกลไก พชต.

2.เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบที่สามารถลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถถอดบทเรียนและขยายผลสู่พื้นที่อื่น

บันไดผลลัพธ์

กิจกรรม

-การจัดประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ

-การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน
-จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงาน พชต. (การจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน)
-การสำรวจต้นทุน และพัฒนาข้อมูลผู้ดื่มฯ (ก่อน-หลัง)
-จัดกิจกรรม "เวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลและกำหนดกติกา/มาตรการชุมชน"

-กิจกรรมติดตามหนุนเสริม และเยี่ยมเสริมพลังและการดำเนินกิจกรรมของ พชต.เครือข่าย
-การประเมิน เฝ้าระวัง และติดตามผล ของเครือข่าย
-ออกแบบและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระดับอำเภอ/ระดับตำบล

-กิจกรรมสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน (กลุ่มเป้าหมาย พชอ. และ พชต. อีก 3 แห่ง)
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชต.
-ประชุมเครือข่าย พชอ.ที่ขับเคลื่อนงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลลัพธ์

เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพพชต. (เครือข่ายระดับตำบล) มีความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์และผลกระทบจากการดื่ม และเกิดมาตรการชุมชนพร้อนโยบายสาธารณะทุกตำบล

พชอ. มีสมรรถนะในการสนับสนุนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีระบบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของพชอ.ราษีไศล และพชต.

ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ

ตัวชี้วัด

-มีคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนที่หลากหลาย มีการทบทวนและแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน
-มีการประชุม และรายงานการประชุมทุกครั้ง
- ข้อมูลผู้ดื่มระดับเสี่ยงสูง, เสี่ยงปานกลาง, และเสี่ยงต่ำ
-มีคณะทำงาน พชต. ที่สามารถขับเคลื่อนงานโดยใช้ข้อมูลไปจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการลดผู้ดื่มระดับเสี่ยงต่างๆ
-มีมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแกนนำเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ
-มีข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

-มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
-มีธรรมนูญอำเภอ/มาตรการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-มีการรณรงค์งานบุญประเพณีลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/มหกรรมคนราษีฯ เมืองสุข คนสุขภาพดีลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

-มีระบบข้อมูลผู้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ละละดับชัดเจน
-มีแผนการติดตามการดำเนินงานการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตำบล ของอำเภอราษีไศล
-มีการรายงานผลผ่านระบบรายงานของอำเภอของพชต.สรุปและประเมินผลทุกเดือน

-ผู้ดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเสี่ยงสูงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20
-เกิดบุคคลต้นแบบลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (6 เดือน) ร้อยละ 5 ของผู้ดื่มกลุ่มเสี่ยงปานกลางและสูง
-มีชุดความรู้ช่วยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครบ 6 ด้าน ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

Grant Chart การดำเนินงานและงบประมาณ

กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											
	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68	ต.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69
1.การจัดประชุมและทบทวนคณะทำงานและพัฒนากลไกคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ	↔											
2.การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน		↔	↔									
3.ออกแบบและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระดับอำเภอ/ระดับตำบล	↔	↔										
4.การสำรวจต้นทุน และพัฒนาข้อมูลผู้ดื่มฯ (ก่อน-หลัง)	↔	↔										
5.จัดกิจกรรม “เวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลและกำหนดกติกา/มาตรการชุมชน”			↔									
6.จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงาน พชต. (การจัดการเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในชุมชน)				↔								
7.การประเมิน เฝ้าระวัง และติดตามผล ของเครือข่าย					↔	↔	↔	↔				
8.กิจกรรมติดตามหนุนเสริม และเยี่ยมเสริมพลังและการดำเนินกิจกรรมของ พชต.เครือข่าย					↔	↔	↔	↔				
9.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชต.									↔	↔		
10.ประชุมเครือข่าย พชอ.ที่ขับเคลื่อนงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์										↔	↔	
11.กิจกรรมสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน (กลุ่มเป้าหมาย พชอ. และ พชต. อีก 3 แห่ง)												↔

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ด้านพฤติกรรมประชาชน

-ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบมีความรู้และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-กลุ่มเป้าหมายสามารถลด ละ หรือเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

-จำนวนผู้ดื่มประจำในชุมชนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ

2.ด้านสังคมและชุมชน

-ชุมชนมีความเข้มแข็งในการรวมพลังต่อต้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-เกิดเครือข่ายภาคประชาชน เช่น แกนนำเยาวชน ครอบครัวต้นแบบ และกลุ่มงดเหล้า

-ลดปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยง

3.ด้านระบบและกลไกชุมชน

-พื้นที่มีแผนชุมชนและกลไกขับเคลื่อนลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นระบบ

-มีต้นแบบกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานที่สามารถถอดบทเรียนเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

-หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายมีบทบาทร่วมกันในการควบคุมและเฝ้าระวังการดื่มแอลกอฮอล์

4.ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-พื้นที่ต้นแบบสามารถพัฒนาเป็น “อำเภอปลอดเหล้า” อย่างยั่งยืน

-มีต้นแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะและสามารถเสนอขยายผลในระดับจังหวัดได้

-ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ผู้รับทุนและผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ- สกุล นางสาวณัฏฐ์นรี คำดี

ตำแหน่งในองค์กร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7446 9459

อีเมลล์ jazzgk9179@gmail.com

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วม

1. นางญาณี สีหบุตร ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ราษีไศล
2. นางวิมลฤดี ไฮคำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ราษีไศล
3. นางพัทยา โพธิวัตน์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านสร้างปี่

ที่ปรึกษา

1. นายณรงค์กร เผื่อแผ่ นายอำเภอราศีไศล
2. นายอรรถวุฒิ ชารีผล สาธารณสุขอำเภอราษีไศล
3. นายจิระวัตร วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล
4. นายศักดาพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์ นักสาธารณสุขชำนาญการ
5. คณะกรรมการพชอ. อำเภอราษีไศล

Q & A
THANK YOU